مؤتمر ومعرض الحج

Hajj Conference & Exhibition

معسكر مستقبل ابتكارات الحج 2026

فايتالينك للحج

نظام تنسيق وتوجيه حالات الطوارئ في المشاعر | نوفمبر 2026
Hajj Emergency Orchestration System

#من_مكة_إلى_العالم

VITALINK

Founder–Problem Fit
أسّسه مسعف بخبرة ميدانية مباشرة
مشكلة نابعة من واقع العمل الإسعافي

من المشاريع الفائزة
هاكاثون هارفارد لابتكار النظم الصحية
Harvard HSIL Hackathon 2026

مقبول سابقاً
برنامج نفكر — وزارة الحج والعمرة
Nafkar Program · Ministry of Hajj and Umrah

01 المشكلة

المشكلة الحقيقية والعاجلة التي يعالجها الحل — هذه الشريحة تجيب: ما المشكلة؟ ومن يعاني منها؟ ولماذا الآن؟

المشكلة في جملة واحدة

حين يسقط حاج في المشاعر بضربة شمس، يصل إلى الطوارئ مجهول الهوية والحالة، والفريق لم يستعد له، ولا أحد يعرف متى يصل — وقد تضيع دقائق ثمينة في التعرّف والتجهيز.

2,764

حالة إجهاد حراري في يوم واحد

أول أيام العيد، حج 1445هـ — وزارة الصحة

من يتأثر بها؟ وأين تحدث في رحلة الحاج؟

الحاج المصاب: كبار السن والمرضى المزمنون أكثر عرضة، وكثير منهم لا يتحدث العربية

المسعف الميداني: يعالج ويوثّق ويبلّغ في الوقت نفسه وسط الزحام

طوارئ المشاعر: تستقبل الحالات دفعات دون إنذار كافٍ

المرحلة: المشاعر — منى وعرفات ومزدلفة، من 8 إلى 13 ذي الحجة

لماذا هي عاجلة الآن؟

حرارة غير مسبوقة: 51.8 درجة مئوية في مكة خلال حج 1445هـ

أعداد متزايدة: رؤية 2030 تستهدف 30 مليون معتمر سنوياً

الخلاصة: في ضربة الشمس كل دقيقة قبل التبريد مهمة؛ وفرضيتنا أن جزءاً منها يضيع عند باب الطوارئ — وهذا أول ما سنقيسه.

02 الأدلة

الأدلة على التحقق من وجود المشكلة — هذه الشريحة تثبت أنكم تحققتم ميدانيًا ولم تفترضوا

Field-Originated Innovation | ابتكار نابع من الخبرة الميدانية

انبثقت VitaLink من الخبرة الإسعافية المباشرة للمؤسس عبدالعزيز خياط، والاستفادة من المعرفة المهنية المحيطة بالفريق، لمعالجة تحديات نقل معلومات الحالات والتنسيق مع أقسام الطوارئ.

التحقق الحالي: خبرة مهنية مباشرة، وتحليل رحلة الحالة، ومراجعة مؤشرات رسمية مرتبطة بطوارئ الحج

فرضية لم تُقس بعد: أن تأخر وصول بيانات الحالة والتجهيز يضيف دقائق عند باب الطوارئ

1,301

وفاة معلنة في حج 1445هـ — وزارة الصحة

83%

منهم غير نظاميين ساروا طويلاً تحت الشمس

51.8°

درجة مئوية، أعلى حرارة في مكة — الأرصاد

> **«كثير من المتوفين لم يحملوا بيانات أو بطاقات تعريفية، فاستغرق التعرّف على هوياتهم وقتاً»**
>
> — مضمون تصريح وزير الصحة فهد الجلاجل، يونيو 2024

التحقق القادم | Next Validation

مقابلات منظمة مع 3–5 ممارسين في الإسعاف والطوارئ، ثم محاكاة تشغيلية تقيس أثر الحل على زمن التسليم والاستعداد

الخلاصة: الأرقام الرسمية تثبت حجم العبء الصحي في المشاعر؛ أما أثر التنسيق على زمن التسليم ففرضية نتحقق منها ميدانياً.

03 المستفيد

من المستفيد؟ ولماذا يهمه هذا الحل؟ — هذه الشريحة ترسم صورة شخص حقيقي لا فئة عامة



نورة، ممرضة طوارئ في مستشفى بمنى

شخصية تمثيلية من واقع طوارئ المشاعر: مناوبات طويلة في ذروة الحج، وحالات تصل دفعات بلا إنذار كافٍ.

احتياجه الأساسي

«أريد أن أعرف من القادم، وما حالته، ومتى يصل... قبل أن يدخل من الباب.»

رحلة الحالة اليوم ونقاط الاحتكاك — تحليل أولي يحتاج قياساً

السقوط والبلاغ	وصول المسعف والتقييم	النقل بالإسعاف	الوصول للطوارئ	التسليم والعلاج
	⚠ الهوية مجهولة	⚠ معلومة محدودة قبل الوصول	⚠ إعادة القياس والإدخال	

لماذا يهمه هذا الحل؟ ماذا يكسب؟

سرير تبريد وفريق جاهزان قبل وصول الحالة، وبيانات الحاج وحساسيته أمامها، وتسليم بلا إعادة إدخال — وقتها للعلاج لا للبحث.

الخلاصة: نورة لا تحتاج نظاماً آخر تُدخل فيه بيانات... تحتاج أن تعرف قبل أن يصل المريض.

04 الحل

وصف الحل وآلية عمله — هذه الشريحة تشرح ماذا تقدمون وكيف يعمل، بلغة بسيطة

الحل في جملة واحدة

نظام لتنسيق وتوجيه حالات الطوارئ في المشاعر: يربط بيانات الحالة وهوية الطوارئ المؤقتة والأولوية بتوصية المستشفى ووقت الوصول وجاهزية الطوارئ والتسليم الرقمي.

ما الذي يختلف؟ سير العمل المعتاد مقابل فايتالينك

سير العمل المعتاد كما رسمناه في التحليل الأولي

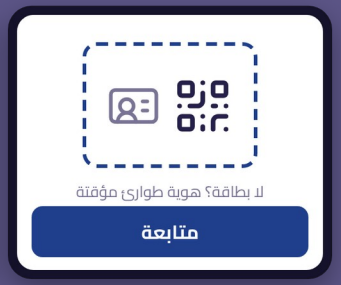
بلاغ أو تواصل محدود ← وصول الحالة ← استكمال البيانات والاستعداد

سير عمل فايتالينك يعمل في النموذج الأولي

توثيق الحالة ← توصية توجيه قابلة للتفسير ← إشعار مسبق ← تأكيد الاستعداد ← تسليم رقمي

نكمّل ولا نستبدل: توجد حلول متقدمة للبلاغات والقيادة والتحكم (مثل مركز الترحيل الطبي وأسعفني)؛ نركّز على طبقة انتقال الحالة من الإسعاف إلى الطوارئ، ونسعى للتكامل معها

01 مسح بطاقة نسك



02 التوثيق الصوتي



03 المراجعة والتأكيد



04 طوارئ المستشفى



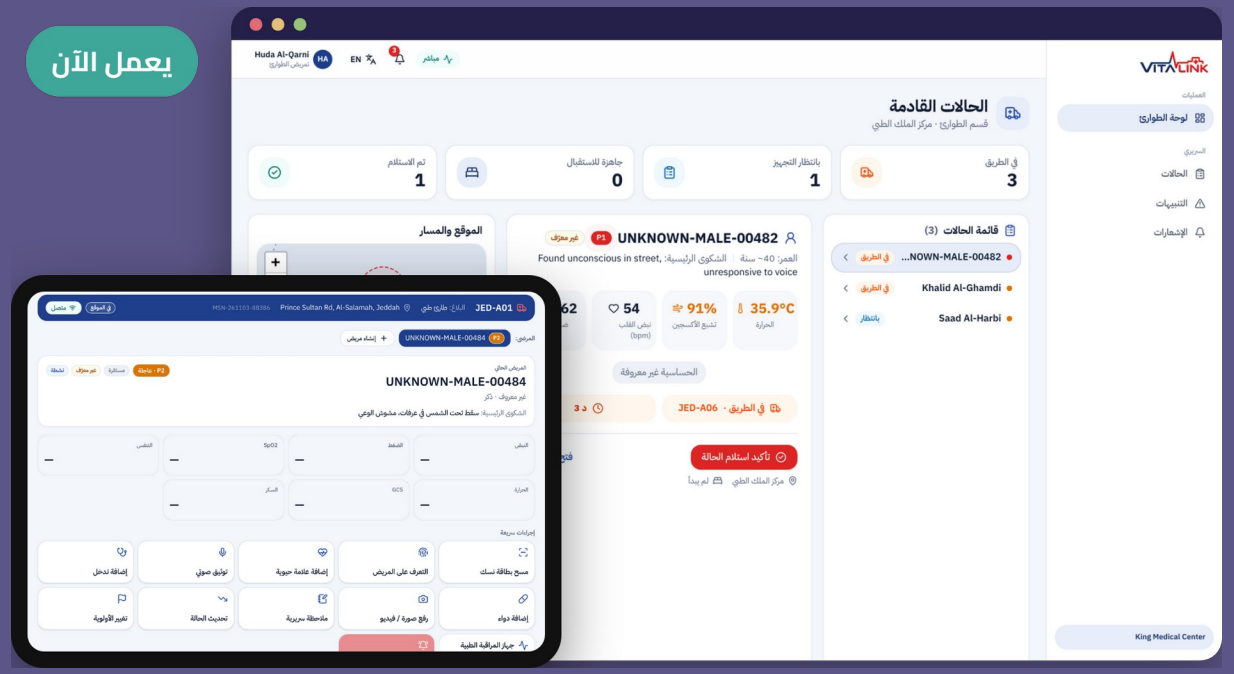
تعمل الآن · بيانات توضيحية · مسح نسك بالمحاكاة

الخلاصة: الحاج يصل... والطوارئ تعرفه وجاهزة له.

05 النموذج الأولي

ما الذي بُني واختُبر فعليًا حتى الآن؟ — هذه الشريحة تعرض ما يعمل اليوم، لا ما تخططون له

يعمل الآن



لقطات حقيقية من المنصة — ببيانات اصطناعية للعرض

ما الذي يعمل فعليًا الآن؟

المسعف: هوية مؤقتة، مسح نسك (محاكاة)، توثيق صوتي، صور — دون إنترنت
التوجيه: توصية مع السبب، والسعة القديمة تُعامل «غير معروفة»
الطوارئ: إشعار لحظي، تأكيد، تجهيز، تسليم رقمي

ما الذي اختبرتموه ومع من؟

ما اختبرناه: 8 سيناريوهات شاملة و36 اختباراً آلياً على بيانات اصطناعية — ناجحة
حدودها: تثبت أن الوظائف تعمل، لا سلامة القرار السريري؛ ولم تُجرَّب مع مستخدمين بعد

ماذا تعلمتم وما الذي غيّرتموه؟

الهوية المجهولة: هوية طوارئ مؤقتة تُطابق لاحقاً
الحر: بروتوكول ضربة الشمس في الفرز
ضياع الجهاز: بيانات مشفّرة وقفل تلقائي

الخلاصة: ليست فكرة على ورق: منصة تعمل اليوم... ونشغّلها أمامكم الآن.

06 الأثر

الأثر المتوقع والقابل للقياس — هذه الشريحة تضع أرقامًا: من أين نبدأ وإلى أين نصل

80%

من حالات P1 بجاهزية مؤكدة قبل وصولها

مستهدف · خط الأساس: لم يُقَس بعد · المقاس: —

30%

خفض زمن التسليم عند الباب

مستهدف · خط الأساس: يُقاس في المحاكاة · المقاس: —

100%

من أوقات الرحلة تُسجَّل آلياً

قدرة موجودة في النموذج: من الإشعار حتى العودة للخدمة

الأثر المتوقع — للحاج والإسعاف والمنظومة

للحاج: سرير وفريق جاهزان قبل وصوله، وحساسيته أمام الفريق

للإسعاف: تسليم أسرع وعودة أسرع للخدمة — مستهدف

للمنظومة: توزيع الحالات حسب السعة، ومؤشرات قابلة للقياس كل موسم

كيف سنقيس؟ محاكاة مقارنة

خط الأساس: قياس زمن التسليم الحالي بساعة مستقلة في محاكاة السير المعتاد

المقارنة: نفس السيناريوهات ونفس الفريق مع فايتالينك — 10 حالات لكل منهما

المؤشرات: زمن التسليم، والجاهزية قبل الوصول، وزمن العودة للخدمة

الخلاصة: مستهدفات للتجربة الأولى تقيسها المنصة نفسها من اليوم الأول — وليست نتائج محققة بعد.

07 التطبيق

قابلية التطبيق والتكامل مع الجهات — هذه الشريحة تجيب: من نحتاج؟ وماذا نحتاج؟ وما الذي قد يعيقنا؟

الجهات الشريكة المطلوبة ودورها

وزارة الصحة: مستشفيات المشاعر، والمشتري الرئيسي
هيئة الهلال الأحمر: الفرق الإسعافية والمسعفون
وزارة الحج والعمرة ونسك: هوية الحاج الرقمية
لجنة الحج المركزية: الإطار المقترح لتنسيق التجربة بين الجهات

نموذج العمل المقترح

المستخدم: المسعفون وفرق الطوارئ في المستشفيات
المشتري والمشغّل: الجهة الصحية (وزارة الصحة / الصحة القابضة) بالتنسيق مع الهلال الأحمر
الإيراد: ترخيص سنوي لكل مستشفى متصل + عقد تشغيل ودعم (SLA) — السعر بعد التجربة
المتطلبات: ربط رسمي بنسك ونفاذ والسجل الصحي، واستضافة داخل المملكة

السلامة والمخاطر: المنفّذ والمخطط

منفّذ: دعم قرار لا قرار — تعديل الفرز بسبب مكتوب، وتغيير الوجهة باعتماد التوجيه، وسجل تدقيق
منفّذ: سعة قديمة تُعامل «غير معروفة»، وعمل دون إنترنت، وبيانات جهاز مشفّرة مع قفل تلقائي
مخطط: مراجعة البروتوكول مع طبيب طوارئ، ومسح الأجهزة عن بُعد، وتحقق ثنائي

الجاهزية والمراحل: CURRENT → NEXT → FUTURE

1 CURRENT · الآن

يعمل ومختبر آلياً: التوثيق والتوجيه والإشعار والجاهزية والتسليم

2 NEXT · حج 1448هـ

مقابلات ومراجعة سريرية ومحاكاة، ثم تجربة بمستشفى في منى

3 FUTURE · بعد 1448هـ

ربط رسمي بنسك ونفاذ والسجل الصحي، ثم المشاعر ومكة والمدينة

الخلاصة: نبدأ ببيئة محاكاة وهوية طوارئ مؤقتة — ولا بيانات مرضى حقيقية قبل الموافقات اللازمة.

08 الخطوة التالية

الخطوة التالية بعد المعسكر — هذه الشريحة تنتهي بطلب واضح ومحدد

ماذا ستفعلون خلال 90 يومًا بعد المعسكر؟

الأسابيع 1–4: مقابلات منظمة مع مسعفين وممرضي طوارئ، وقياس زمن التسليم الحالي

الأسابيع 5–8: محاكاة مقارنة: السير المعتاد مقابل فايتالينك بنفس الفريق والسيناريوهات

الأسابيع 9–12: مراجعة البروتوكول مع طبيب طوارئ، وتقديم طلب تجربة لحج 1448هـ

الفريق والأدوار

عبدالعزيز خياط: المؤسس والرئيس التنفيذي والمسؤول السريري — مسعف بخبرة ميدانية مباشرة، وصاحب براءة اختراع لعلاج دوائي

رناس عبدالله مرير: الشريك المؤسس والرئيس التقني — المعمارية والأمن السيبراني، ومتطوع تقني سابق مع الهلال الأحمر

زيد محمد الخزاعي: التحول الرقمي وإدارة المشروع، متدرب بوكالة التحول الرقمي بوزارة الحج والعمرة

عبدالرحمن موتة: ريادة الأعمال ونموذج العمل، وهندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي

الدعم المطلوب

احتضان: برنامج مسرّعة صحية أو حكومية

وصول تجريبي: بيئة تجريبية (Sandbox) لنسك ونفاذ

شريك سريري: مستشفى واحد بالمشاعر

الميزانية التأسيسية: 250 ألف ر.س — تقدير تخطيطي مبدئي: بيئة التجربة، والأجهزة، والأمن، والتحقق السريري، والتدريب، والتشغيل

الطلب الواضح من المحكّمين والجهات

نطلب مستشفى واحداً في منى وفريقاً من الهلال الأحمر: محاكاة أولاً، ثم تجربة ميدانية محدودة في حج 1448هـ بعد الموافقات.

هدفنا من المشاركة: تطوير المشروع وبدء التجارب الأولية بالتعاون مع الجهات ولجنة الحج المركزية

الخلاصة: طلب واحد واضح: مستشفى واحد وموسم واحد... لنثبت الأثر بالأرقام.

مؤتمر ومعرض الحج

Hajj Conference & Exhibition

معسكر مستقبل ابتكارات الحج 2026

شكرًا لكم

الحاج يصل... والطوارئ تعرفه وجاهزة له

طلبنا: مستشفى واحد وفريق إسعاف — محاكاة ثم تجربة في حج 1448هـ

أسئلة ونقاش

للتواصل: عبدالعزيز خياط، المؤسس والرئيس التنفيذي

+966 53 026 2035 · X: @acutepower